

الإدمان واضطرابات تعاطي المواد

من الفهم العلمي إلى الممارسة الإكلينيكية

محمد القحطاني | باحث دراسات عليا في علم النفس الإكلينيكي
أخصائي نفسي - مصنف من هيئة التخصصات الصحية



أهداف الورشة

بنهاية هذه الورشة سيكون المتدرب قادرًا على تحقيق المخرجات التعليمية التالية:

01

المفاهيم الأساسية

فهم المفاهيم الأساسية في علاج الإدمان والتمييز بين أنواع المواد النفسية المختلفة.

03

التقييم والتشخيص

تقييم اضطراب تعاطي المواد وفق المعايير التشخيصية المعتمدة.

02

آليات الإدمان

فهم كيف يتطور الإدمان والتغيرات الدماغية المصاحبة له على المستوى العصبي.

04

التدخل العلاجي

التعرف على أهم التدخلات العلاجية والتعامل مع الانتكاسة بصورة علمية ومنهجية.

لماذا ندرس الإدمان؟

الحجم العالمي للمشكلة

296M

مستخدم للمواد

شخص حول العالم يتعاطون مواد ذات تأثير نفسي سنويًا (UNODC 2023)

39M

مصابون بالاضطراب

يعانون من اضطراب تعاطي المواد بشكل إكلينيكي (WHO)

7%

فجوة العلاج

فقط 7% ممن يحتاجون العلاج يحصلون عليه فعليًا (SAMHSA)

\$600B

العبء الاقتصادي

التكلفة السنوية التقديرية على الاقتصاد الأمريكي وحده من الجريمة والصحة وفقدان الإنتاجية

المفاهيم الأساسية

نبدأ بتأسيس لغة مشتركة وفهم مشترك للمصطلحات العلمية

ما المقصود بالمادة ذات التأثير النفسي؟

المادة ذات التأثير النفسي (Psychoactive Substance) هي أي مادة كيميائية تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى تغييرات في الوعي، والمزاج، والإدراك، أو السلوك. وهي تشمل المواد المشروعة وغير المشروعة على حدٍ سواء.



النيكوتين

منبه شديد الإدمان، يُستنشق عبر التبغ والسجائر الإلكترونية.



المنومات

البنزوديازيبينات والباربيتورات المستخدمة في علاج القلق والأرق.



الكافيين

المنبه الأكثر استهلاكًا في العالم، موجود في القهوة والشاي.



الأفيونات

مسكنات قوية للألم تشمل المورفين والهيريون والفتانيل.

أهم المصطلحات الإكلينيكية

يُعدّ التمييز الدقيق بين هذه المصطلحات ركيزةً أساسية في التواصل المهني والتشخيص السليم.

المصطلح الإنجليزي	المصطلح العربي	التعريف
Use	التعاطي	استخدام المادة بصورة اعتيادية دون أضرار واضحة أو فقدان للسيطرة.
Misuse	سوء الاستخدام	استخدام المادة بطريقة تختلف عن الغرض المحدد لها أو خارج التوجيهات الطبية.
Harmful Use	الاستخدام الضار	نمط استخدام يُسبب ضررًا جسديًا أو نفسيًا موثقًا دون استيفاء معايير الاعتماد.
Dependence	الاعتماد	حالة فسيولوجية أو نفسية تتسم بالحاجة الملحة للمادة لتفادي أعراض الانسحاب.
Addiction	الإدمان	نمط سلوكي قهري مزمن يستمر رغم العواقب السلبية الواضحة.
Substance Use Disorder	اضطراب تعاطي المواد	المصطلح التشخيصي المعتمد في DSM-5-TR ويشمل طيفًا من الخفيف إلى الشديد.

الإدمان أم اضطراب تعاطي المواد؟

تحول تشخيصي مهم في DSM-5-TR

"الإدمان" مصطلح شعبي وبحثي، أما التشخيص الرسمي فهو Substance Use Disorder.

لماذا التغيير؟

أزال الـ DSM-5-TR مصطلح "Addiction" من التصنيف الرسمي لتجنب الوصمة والتحيز، واستُبدل بمصطلح Substance Use Disorder الذي يعكس طبيعة الاضطراب كطيف متدرج يتراوح بين الخفيف والمتوسط والشديد.

ما الذي تغيّر؟

- إلغاء الفصل بين "الإساءة" و"الاعتماد".
- اعتماد نظام التدرج (خفيف، متوسط، شديد).
- التركيز على الأنماط السلوكية والوظيفية.

مصطلحات إكلينيكية لا غنى عنها

الانسحاب — Withdrawal

أعراض جسدية ونفسية تظهر عند التوقف أو التخفيض المفاجئ بعد الاستخدام المطول.

التحمل — Tolerance

الحاجة إلى كميات متزايدة من المادة للحصول على التأثير ذاته، أو تراجع التأثير مع الجرعة المعتادة.

التسمم — Intoxication

التأثير الحاد المباشر للمادة على الجهاز العصبي عقب الاستهلاك.

الشغف — Craving

رغبة ملحة وقهرية في الحصول على المادة، وهي أحد المحركات الرئيسية للانتكاسة.

التعافي / الانتكاسة / الهدأة

Recovery: مسيرة التحسن المستدام. Relapse: العودة للاستخدام. Remission: غياب المعايير التشخيصية لمدة محددة.

إزالة السموم — Detoxification

المرحلة الطبية الأولى من العلاج لإدارة أعراض الانسحاب بأمان تحت إشراف متخصص.

أنواع المواد

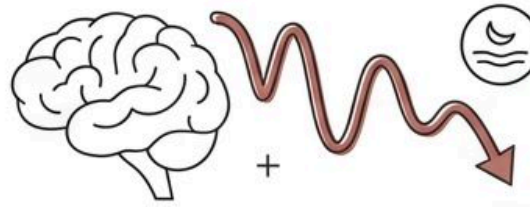
تصنيف المواد النفسية وفق تأثيراتها على الجهاز العصبي المركزي

تصنيف المواد حسب تأثيرها

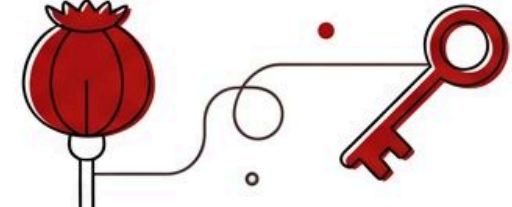
تُصنّف المواد ذات التأثير النفسي وفق آلية عملها على الجهاز العصبي المركزي، مما يحدد تأثيراتها وأعراض انسحابها وخطورتها الإكلينيكية.



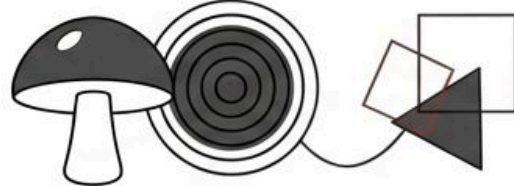
المنشطات (Stimulants)
ترفع النشاط والتنبه



المثبطات (Depressants)
تخفض نشاط الجهاز العصبي



الأفيونات (Opioids)
تسكين الألم وإحداث النشوة



المهلوسات (Hallucinogens)
تشويه الإدراك الحسي



المنفصلات (Dissociatives)
انفصال عن الواقع

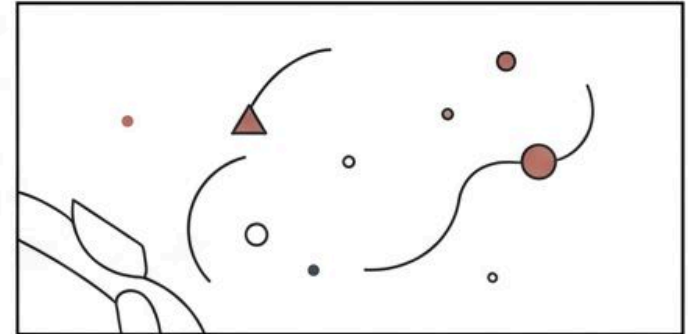
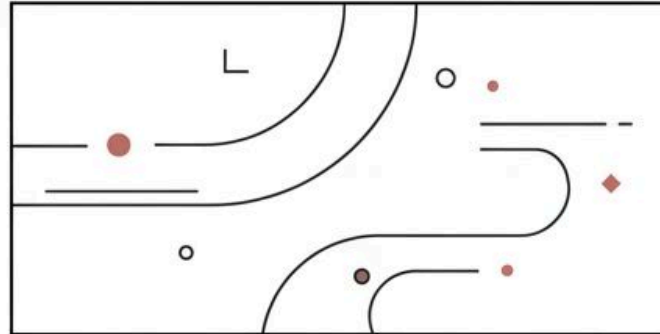


القنب (Cannabis)
تأثيرات مختلطة



المستنشقات (Inhalants)

مواد تستنشق وتسبب التخدير



المنشطات — Stimulants

تعمل المنشطات على رفع مستوى النشاط في الجهاز العصبي المركزي عبر زيادة إفراز الدوبامين والنورأدرينالين، مما يحدث شعورًا مؤقتًا بالطاقة والنشاط والثقة.



النيكوتين

منبه خفيف لكنه شديد الإدمان لأنه يصل إلى الدماغ بسرعة عبر الرئتين. قد يُشعر المستخدم بالتنبيه أو التهذئة بحسب الجرعة والسياق، لكن الإقلاع عنه صعب جدًا، إذ تتجاوز نسب الانتكاس 90% دون دعم علاجي. وترتبط آثاره طويلة الأمد بأمراض القلب والرئة والسرطان.



الكوكايين

يعمل عبر إعاقة إعادة امتصاص الدوبامين، لذلك يمنح نشوة سريعة لكنه قصير المدة غالبًا 30-60 دقيقة، ما يدفع لتكرار الجرعات. تشمل أعراض التسمم الثقة المفرطة وتسارع ضربات القلب والتنبيه الشديد، مع خطر حقيقي لاضطرابات القلب والسكتات الدماغية حتى لدى الشباب الأصحاء.



الأمفيتامين والميثامفيتامين

يرفعان إفراز الدوبامين والنورأدرينالين بشكل حاد، ويُستهلكان بالاستنشاق أو الحقن أو التدخين. قد يسببان فرط نشاط وجنون عظمة وعدوانية، ومع الجرعات العالية قد يظهر ذهان حاد أو مضاعفات قلبية خطيرة. يترك التعاطي آثار انسحاب شديدة تشمل اكتئابًا عميقًا وإرهاقًا ورغبة قهرية، كما أن الشبو واسع الانتشار محليًا.

المثبطات — Depressants

كيف تعمل؟

تثبّت المثبطات نشاط الجهاز العصبي المركزي عبر تعزيز عمل الـ GABA (الناقل التثبيطي)، مما يُنتج تأثيرات مهدئة ومزيلة للقلق.



الانسحاب المفاجئ من المثبطات — خاصة الكحول والبنزوديازيبينات — قد يكون مُهدّدًا للحياة ويستلزم إشرافًا طبيًا.



الباربيتورات

كانت تُستخدم قديمًا لعلاج القلق والصرع وللتخدير، لكنها تراجعت كثيرًا في الاستخدام الطبي. السبب الرئيسي هو أن هامش الأمان بينها وبين الجرعة القاتلة ضيق جدًا، ما يجعل الجرعة الزائدة خطرًا حقيقيًا حتى عند حدوث أخطاء بسيطة. لذلك استُبدلت غالبًا بالبنزوديازيبينات الأكثر أمانًا والأقل سُميّة.



البنزوديازيبينات

مثل الديازيبام والألبرازولام، وتُستخدم طبيًا لعلاج القلق والأرق وبعض حالات التشنجات. ورغم فائدتها السريرية، فإن خطر الاعتماد يزداد بوضوح مع الاستخدام المستمر، خصوصًا إذا تجاوز الأسبوعين. كما أن دمجها مع الكحول أو الأفيونات شديد الخطورة، لأنه قد يؤدي إلى تثبيط تنفسي قاتل وإغماء عميق.



الكحول

يُعد أكثر المواد المثبطة تعاطيًا عالميًا. يحدث تثبيطًا تدريجيًا للجهاز العصبي المركزي يعتمد على الجرعة، فيبدأ بخفض التثبيط الاجتماعي وقد يتطور إلى اضطراب التوازن والكلام والوعي. وعلى المدى الطويل يرتبط بأضرار صحية كبيرة تشمل تليف الكبد، وأمراض القلب، وزيادة خطر السرطان. أما الانسحاب فقد يكون خطيرًا جدًا، مع رجفة وتشنجات وهلاوس، وقد يصل إلى *Delirium Tremens* المهدّد للحياة.

الأفيونات — Opioids

تشكّل أزمة الأفيونات أحد أخطر تحديات الصحة العامة عالميًا. تعمل الأفيونات على مستقبلات الألم الطبيعية في الدماغ مُنتجةً تسكينًا قويًا للألم ونشوةً عارمة.



أوكسيكودون وكوديين

مسكّنات مشروعة تُوصف للألم المتوسط إلى الشديد، ويبدأ خطر إساءة الاستخدام غالبًا من وصفة طبية مشروعة قبل التحول لتعاطٍ قهري.



الفنتانيل

مسكّن اصطناعي أقوى بـ 100 مرة من المورفين، يُستخدم طبيًا بجرعات دقيقة جدًا، لكنه أصبح السبب الرئيسي لحالات الوفاة بالجرعة الزائدة عالميًا بسبب خلطه خفية بمواد أخرى.



الهيروين

يُصنّع من المورفين، يصل للدماغ خلال ثوانٍ عبر الحقن مُحدثًا نشوة شديدة، ويحمل أعلى معدلات الإدمان والجرعة الزائدة بين الأفيونات، مع مخاطر صحية إضافية مرتبطة بالحقن مثل الالتهابات والأمراض المنقولة بالدم.



المورفين

المسكّن الأصلي المستخلص من الأفيون، يُستخدم طبيًا في علاج الألم الحاد والسرطاني تحت إشراف طبي دقيق، مع خطر تطور التحمل والاعتماد عند الاستخدام المطوّل.

المهلوسات والقنب

القنب — Cannabis

يحتوي القنب على مئات المركبات أبرزها:

- المركب النفسي المسؤول عن التأثير المُهلّس والنشوة: THC.
- مركب غير نفسي يُدرس لخواصه المضادة للقلق والصرع: CBD.

من مضاعفاته: اضطراب القلق، الذهان لدى الفئات الحساسة، متلازمة إدمان القنب عند الاستخدام المطوّل.

المهلوسات — Hallucinogens

تُشوّه المهلوسات الإدراك الحسي والزمني وتُحدث تجارب خارج المألوف. لا تُسبب اعتمادًا جسديًا تقليديًا لكنها تحمل مخاطر نفسية.

- يؤثر على مستقبلات السيروتونين، تأثيراته تستمر 8-12 ساعة: LSD.
- موجود في "الفطر السحري"، قيد الدراسة علاجيًا للاكتئاب: Psilocybin.
- LSD مستخلص نباتي ذو تأثيرات مشابهة لـ: Mescaline.

أكثر المواد شيوعًا في المملكة العربية السعودية

يُتيح فهم نمط انتشار المواد محليًا توجيه الجهود الوقائية والعلاجية بشكل أكثر دقة وفعالية.



الشبو (ميثامفيتامين)

منشط قوي شديد الإدمان، تصاعد انتشاره بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.



الحشيش

أكثر المواد غير المشروعة تداولًا في المملكة.



النيكوتين

الأكثر انتشارًا وتقبُّلاً اجتماعيًا، معدلات تدخين مرتفعة بين الشباب.



إساءة المهدئات والمسكّنات

إساءة استخدام المهدئات والمسكّنات الأفيونية في تزايد ملحوظ وتستدعي يقظة إكلينيكية.



الكتاجون

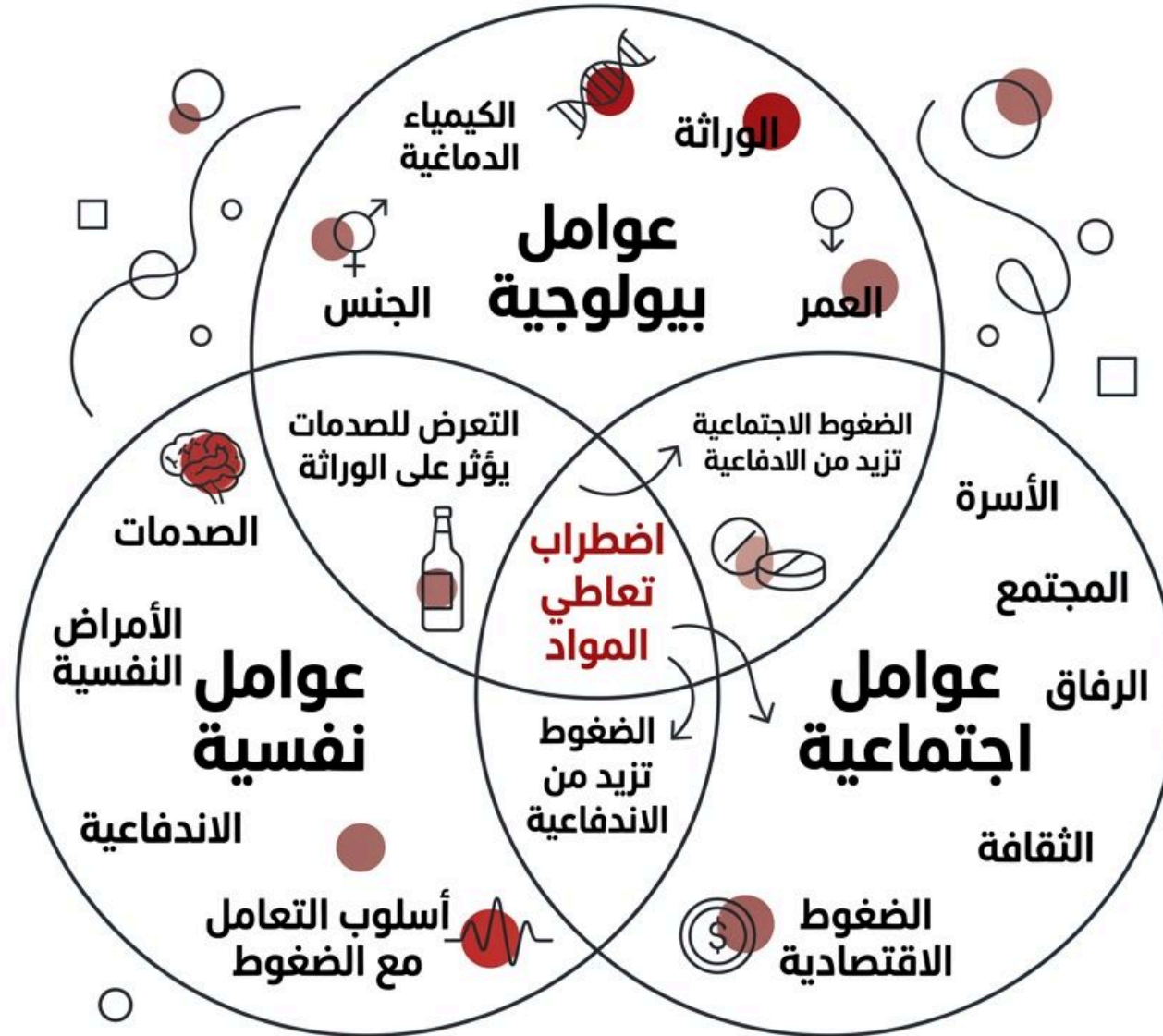
منشط صناعي ينتشر في منطقة الشرق الأوسط، شائع في أوساط الشباب.

كيف يحدث الإدمان؟

فهم الآليات المؤدية إلى تطور اضطراب تعاطي المواد

النموذج البيولوجي النفسي الاجتماعي

لا يُفسّر الإدمان بعامل واحد، بل هو نتاج تفاعل معقد بين عوامل متعددة المستويات. النموذج البيو-سيكو-اجتماعي هو الإطار الأشمل والأكثر قبولاً في الأدبيات الحديثة.



عوامل الخطورة

كلما تراكمت عوامل الخطورة، ارتفع احتمال تطور الاضطراب. ولا يعني وجود عامل خطورة حتمية الإصابة، بل زيادة القابلية.

عوامل فردية وبيولوجية

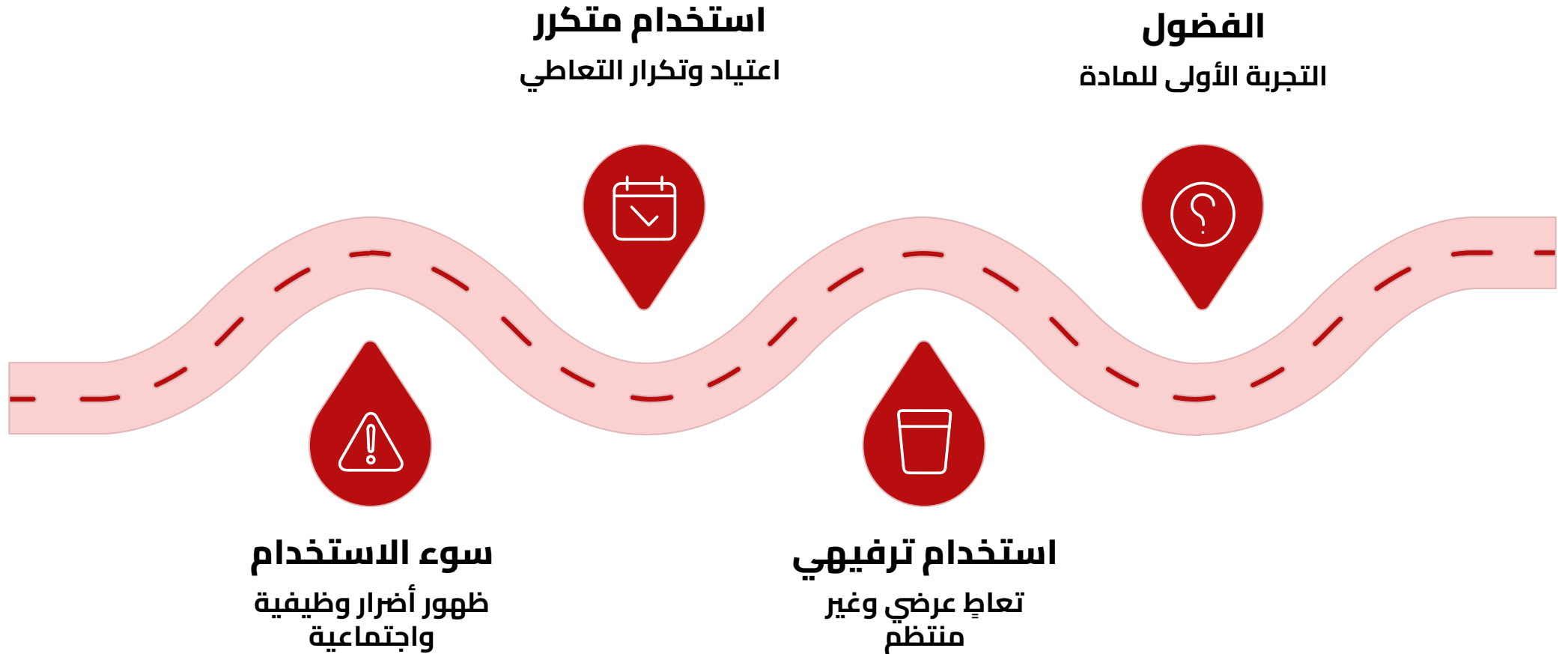
- الوراثة: تُفسّر 40-60% من قابلية الإدمان.
- الاندفاعية: ضعف التحكم في الاندفاع مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإدمان.
- الصدمات النفسية: خاصة صدمات الطفولة (ACEs).
- اضطرابات الشخصية: لا سيما شخصية الحدية والمضادة للمجتمع.

عوامل نفسية واجتماعية

- الاكتئاب والقلق: قد يُستخدم التعاطي كآلية تكيف.
- بيئة الأسرة: الإهمال أو الإساءة أو وجود مدمن في الأسرة.
- ضغط الرفاق: مؤثر بشكل خاص في مرحلة المراهقة.
- سهولة الحصول على المادة: متغير بيئي مؤثر.

دورة تطور الإدمان

يمر الإدمان بمراحل متتالية تتطور تدريجيًا. فهم هذه المراحل يُساعد المتخصص على التدخل المبكر قبل استفحال الاضطراب.



تجدر الإشارة إلى أن الانتقال بين المراحل ليس حتميًا أو خطيًا دائمًا، إذ يتأثر بعوامل الخطورة والحماية في كل مرحلة.

الدماغ والإدمان

فهم التغيرات العصبية التي تجعل الإدمان اضطرابًا دماغيًا

نظام المكافأة الدماغية

يعمل الإدمان عبر اختطاف نظام المكافأة الطبيعي في الدماغ. هذا النظام تطوّر أصلاً لتعزيز السلوكيات البقاءية كالأكل والتكاثر.



والنواة المتكئة VTA

المنطقة الجسرية (VTA) تُرسل الدوبامين إلى النواة المتكئة (Nucleus Accumbens) مُنتجةً الشعور بالمتعة.



الدوبامين

الناقل العصبي الرئيسي للمكافأة. تُطلق المواد كميات تفوق الطبيعية بعشرات الأضعاف، مما يُولّد نشوة استثنائية.



القشرة الأمامية

مركز اتخاذ القرار والتحكم في الاندفاع. يتراجع نشاطها مع الإدمان: Prefrontal Cortex: مما يُضعف القدرة على الإحجام.

لماذا لا يستطيع التوقف؟

الشرح العلمي

مع تكرار الاستخدام، يتكيف الدماغ بتقليل مستقبلات الدوبامين (Downregulation). النتيجة: المادة لا تُعطي الشعور المنشود بعد الآن (تراجع اللذة)، لكن الدماغ المُعاد برمجته يظل يُولّد رغبة قسرية (Craving) في حضور أي مثير مرتبط بها.

الأثر الإكلينيكي

هذا يفسّر لماذا يصعب على المريض الإقلاع بمحض إرادته، ولماذا الوصفة والتوبيخ غير فعالين علاجياً.

Wanting ≠ Liking

أحد أهم مفاهيم علم الأعصاب في الإدمان: الرغبة والمتعة دوائر دماغية مختلفة.

"المدمن يَشْتَاق إلى المادة لكنه لا يستمتع بها كما كان في البداية"

التغيرات الدماغية المزمنة

الإدمان المزمن يُغيّر بنية الدماغ ووظيفته بصورة يمكن قياسها بالتصوير الدماغى. هذه التغيرات قابلة للتعافى جزئياً أو كلياً مع الامتناع المستدام.



التعلم والذاكرة

تُكوّن المادة ذكريات ارتباطية قوية جدًا تُنشّط
بالمثيرات البيئية وتُحرّك الشغف.



التحكم في الاندفاع

صعوبة مقاومة الرغبات الآنية والمثيرات البيئية
المرتبطة بالمادة.



الوظائف التنفيذية

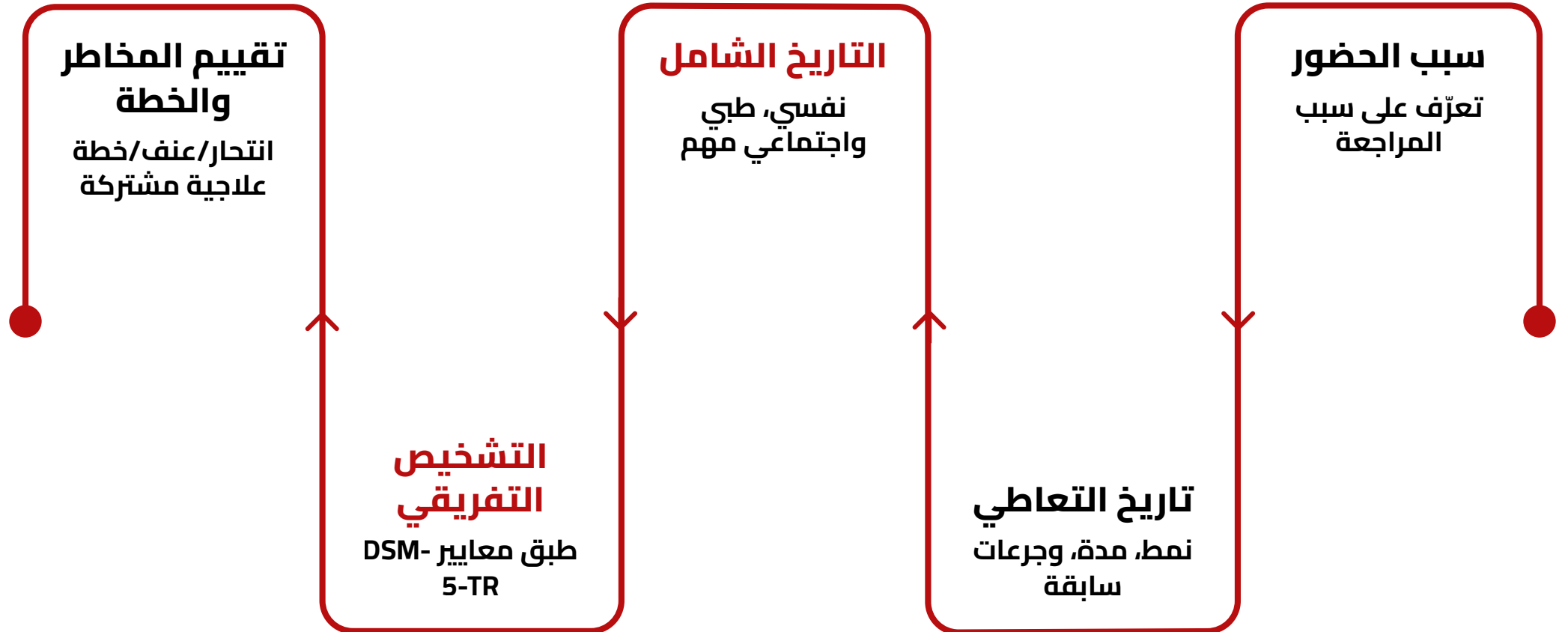
تراجع فى التخطيط، اتخاذ القرار، وضبط الاندفاع
بسبب ضعف نشاط القشرة الأمامية.

التقييم الإكلينيكي

خطوات المقابلة والتشخيص الشامل

خطوات المقابلة التشخيصية

تُشكّل المقابلة المنظّمة حجر الزاوية في تقييم اضطراب تعاطي المواد. اتبع هذا المسار المنطقي لضمان تقييم شامل وموثوق.



يُنصح بإكمال التقييم على مراحل متعددة لا في جلسة واحدة، مع مراعاة التحالف العلاجي منذ اللقاء الأول.

معايير التشخيص — DSM-5-TR

يعتمد DSM-5-TR على 11 معيارًا تدرج في أربعة محاور رئيسية. تحدد الشدة بعدد المعايير المستوفاة: 2-3 خفيف، 4-5 متوسط، 6 فأكثر شديد.

التأثير على الأداء

إهمال الالتزامات الأسرية والمهنية والتعليمية، التخلي عن الأنشطة الاجتماعية والمهنية المحببة بسبب التعاطي.

ضعف السيطرة

الاستخدام بكميات أكبر أو فترات أطول من المقصود، محاولات فاشلة للتوقف، قضاء وقت طويل في الحصول على المادة، والشغف القهري.

المؤشرات الدوائية

التحمل (الحاجة لجرعات أعلى)، والانسحاب (أعراض عند التوقف)، ولا ينطبق هذا المعيار على الاستخدام الطبي المشروع.

الاستخدام رغم الأضرار

الاستمرار في التعاطي رغم علمه بمشاكل جسدية ونفسية واجتماعية ناجمة عنه، أو الاستخدام في مواقف خطيرة.

الاضطرابات النفسية المصاحبة — Comorbidities

تشير الدراسات إلى أن ما يزيد على 50% من المصابين باضطراب تعاطي المواد يعانون من اضطراب نفسي مصاحب. التشخيص الثنائي ضروري لتحقيق استجابة علاجية فعّالة.



الذهان واضطرابات الشخصية

التعاطي المزمن قد يُحرّض ذهانيًا، كما أن اضطرابات الشخصية الحدية والمضادة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإدمان.



الصدمات — PTSD

ارتباط قوي بين صدمات الطفولة واضطراب ما بعد الصدمة واضطراب تعاطي المواد.



القلق

يستخدم كثيرون المهدئات أو الكحول لتخفيف أعراض القلق، مما يُهيئ لدورة اعتماد متصاعدة.



الاكتئاب

الأكثر شيوعًا. قد يكون التعاطي محاولةً للتخفيف من أعراضه، أو قد يكون الاكتئاب ناجمًا عن المادة.

العلاج

من إزالة السموم إلى التعافي المستدام

العلاج الدوائي — Pharmacotherapy

تُستخدم الأدوية كجزء من خطة علاج متكاملة لتخفيف الأعراض، تقليل الرغبة الشديدة، ودعم التعافي حسب نوع المادة.

المنشطات

- لا يوجد دواء معتمد بشكل واسع حتى الآن
- يعتمد العلاج على الدعم السلوكي والمتابعة

الكحول

- النالتريكسون
- أكامبروسيت
- ديسلفيرام

الأفيونات

- الميثادون
- البوبرينورفين
- النالتريكسون



يجب أن يتم اختيار العلاج الدوائي وتعديله تحت إشراف طبي مباشر، مع متابعة الآثار الجانبية والتداخلات الدوائية.

برنامج الـ 12 خطوة — Twelve-Step Program

يُعد برنامج الاثنتي عشرة خطوة، الذي نشأ مع زمالة المدمنين المجهولين (AA/NA)، أساسًا قويًا للتعافي من اضطرابات تعاطي المواد. يعتمد على الدعم الجماعي والنمو الشخصي والروحي، وقد أثبتت فعاليته في مساعدة الملايين حول العالم على تحقيق التعافي المستدام.

01	الاعتراف بالعجز الإقرار بأننا عاجزون أمام إدماننا وأن حياتنا أصبحت لا تُدار.
02	الإيمان بقوة أكبر الإيمان بأن قوة أعظم منا يمكن أن تُعيدنا إلى عقل سليم.
03	اتخاذ قرار تسليم إرادتنا وحياتنا لعناية الله، حسب مفهومنا له.
04	جرد أخلاقي القيام بجرد أخلاقي وجريء لذاتنا.
05	الاعتراف بالعيوب الاعتراف أمام الله، أنفسنا، وشخص آخر بطبيعة أخطائنا.
06	الاستعداد للتغيير الاستعداد التام لأن يُزيل الله كل هذه العيوب الخلقية.
07	طلب الإزالة طلب التواضع من الله أن يُزيل نقائصنا.
08	قائمة المتضررين وضع قائمة بكل الأشخاص الذين أضررنا بهم، والاستعداد لتصحيح أخطائنا معهم.
09	التعويض المباشر تصحيح أخطائنا مباشرة مع هؤلاء الأشخاص، متى أمكن ذلك، إلا إذا كان من شأن ذلك أن يُضرّ بهم أو بآخرين.
10	استمرار الجرد الاستمرار في جرد ذاتنا، وعندما نخطئ، نعتزف بذلك فورًا.
11	الصلاة والتأمل السعي لتحسين اتصالنا الواعي بالله، حسب مفهومنا له، من خلال الصلاة والتأمل، طالبين معرفة إرادته والقوة لتنفيذها.
12	اليقظة الروحية والمساعدة بعد يقظة روحية نتيجة لهذه الخطوات، محاولة إيصال هذه الرسالة للمدمنين وممارسة هذه المبادئ في جميع شؤون حياتنا.



يعتمد البرنامج على مفهوم "القوة العليا" كإطار روحي، وليس دينيًا بالضرورة، مما يجعله مناسبًا للأشخاص من خلفيات معتقدات مختلفة.

نموذج ماتريكس — The Matrix Model

نبذة تاريخية

ظُور نموذج ماتريكس في الثمانينيات في كاليفورنيا، خصيصًا لعلاج اضطراب تعاطي المنشطات مثل الكوكايين والميثامفيتامين، ويُعد من البرامج الرائدة في هذا المجال.

مدة البرنامج

يتميز بكونه برنامجًا علاجيًا مكثفًا يستمر لمدة 16 أسبوعًا، مُصممًا لتقديم دعم شامل على مدار هذه الفترة.

الاعتماد والأدلة

النموذج معتمد من إدارة خدمات تعاطي المواد والصحة النفسية (SAMHSA) في الولايات المتحدة، ومدعوم بأدلة علمية قوية تثبت فعاليته.

"نموذج ماتريكس ليس مجرد علاج، بل خارطة طريق لاستعادة السيطرة والحياة"

المكونات العلاجية الأساسية

يعتمد نموذج ماتريكس على مزيج من العلاج الفردي والجماعي لتوفير دعم شامل ومتعدد الأوجه في رحلة التعافي من اضطراب تعاطي المواد.

العلاج الجماعي

مجموعات تعليمية وجلسات لإعادة الوقاية من الانتكاسة، توفر بيئة داعمة لتبادل الخبرات وتطوير مهارات التأقلم مع دعم الأقران.

العلاج الفردي

جلسات أسبوعية مكثفة مع معالج متخصص، تركز على تحديد المثيرات، وضع خطة تعافي شخصية، وتعزيز الدافعية نحو التغيير المستدام.

الدعم الأسري والمجتمعي

يُعد الدعم الأسري والمجتمعي عنصرًا حيويًا في نموذج ماتريكس، حيث يوفر للمتعاقي بيئة مستقرة وداعمة تُعزز من فرص التعافي المستدام وتُقلل من مخاطر الانتكاس.



اختبارات البول الدورية

تُستخدم كأداة للمساءلة وليس للعقاب، تعزز الثقة المتبادلة بين المريض والأسرة، وتؤكد الامتناع عن التعاطي.



مجموعات الدعم الذاتي

الاندماج في برامج الدعم الذاتي مثل NA/AA كمكمل حيوي للعلاج، لبناء شبكة دعم اجتماعي قوية ومستدامة.

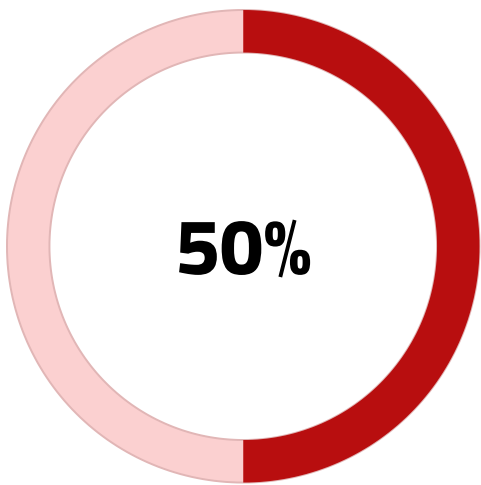


التثقيف الأسري

جلسات تعليمية للأسرة لفهم الإدمان، تصحيح الديناميكيات الأسرية، وتدريبهم على الاستجابة الصحيحة لدعم التعافي.

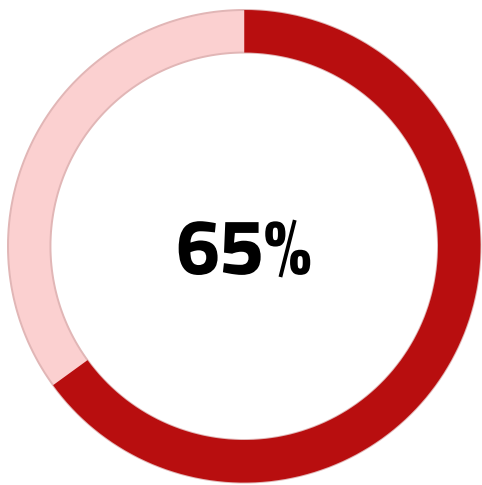
الفعالية والأدلة العلمية

يُعرف نموذج ماتريكس بفعاليته المثبتة في علاج اضطراب تعاطي المنشطات، وهو مدعوم بعدة دراسات تبرز نتائجه الإيجابية مقارنةً بالأساليب التقليدية.



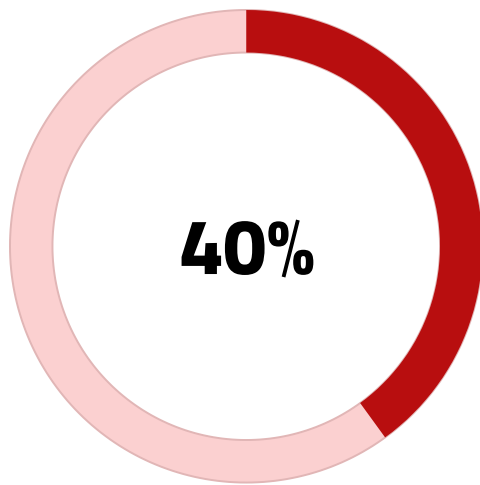
زيادة الامتناع

تحسين كبير في مدة الامتناع عن التعاطي مقارنةً بالعلاجات الأخرى.



إكمال البرنامج

نسبة عالية من المشاركين الذين يكملون البرنامج العلاجي بنجاح.



تقليل الانتكاسة

انخفاض ملحوظ في معدلات الانتكاس بعد إكمال البرنامج.

مقارنة: نموذج ماتريكس مقابل العلاج التقليدي

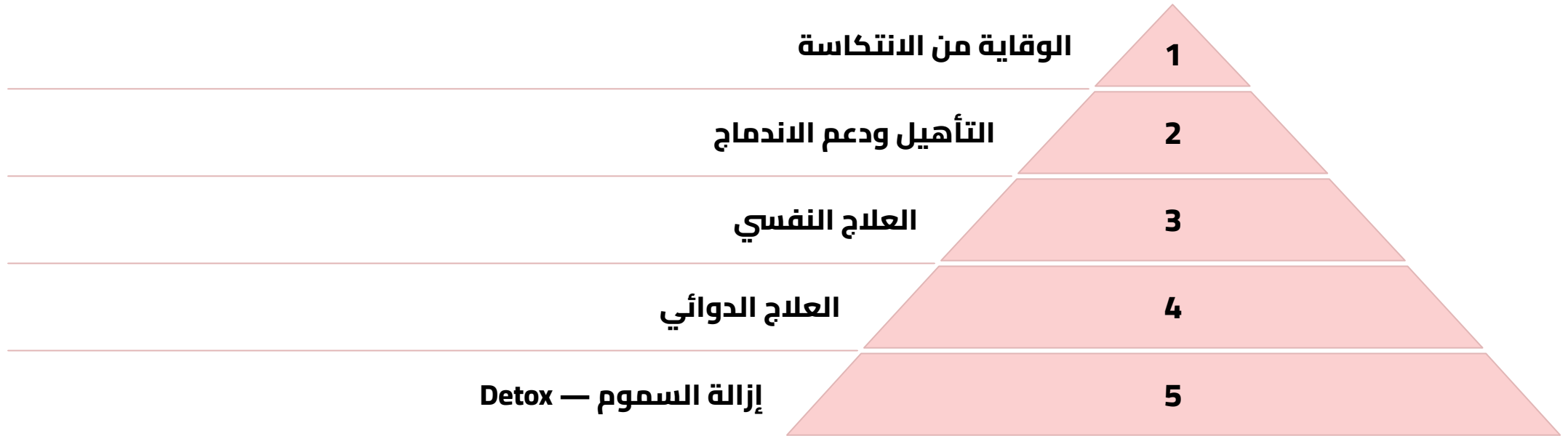
[30,35,35]

الميزة	نموذج ماتريكس	العلاج التقليدي
التركيز الرئيسي	مصمم خصيصًا لعلاج اضطراب تعاطي المنشطات.	نطاق أوسع، قد لا يكون متخصصًا للمنشطات.
المدة والكثافة	مكثف، عادةً 16 أسبوعًا بجدول زمني محدد.	قد يختلف في المدة والكثافة، غالبًا أقل تنظيمًا.
المكونات العلاجية	علاج فردي وجماعي، تثقيف أسري، اختبار مخدرات دوري.	يركز على جلسات فردية أو جماعية، قد يفتقر لبعض المكونات.
الدعم الأسري	مكون أساسي لتعزيز التعافي ودعم البيئة المنزلية.	قد يكون اختياريًا أو أقل تكاملًا في الخطة العلاجية.
الأدلة العلمية	مدعوم بأبحاث قوية تثبت فعاليته المحددة.	تختلف الأدلة حسب النهج العلاجي ونوع الإدمان.

صنفت إدارة خدمات تعاطي المواد والصحة النفسية (SAMHSA) في الولايات المتحدة نموذج ماتريكس ضمن البرامج العلاجية المدعومة بالأدلة العلمية، مما يؤكد جودته وفعاليته.

هرم العلاج المتكامل

العلاج الفعّال ليس حدثًا واحدًا بل مسيرة متدرجة تبدأ بالسلامة الجسدية وتصل إلى التعافي الشامل والمستدام.



يبدأ الهرم من قاعدة إزالة السموم كمرحلة طبية طارئة وصولًا إلى الوقاية من الانتكاسة كهدف مستدام طويل الأمد.

التدخلات النفسية الفعّالة

تتوفر أدلة علمية قوية لعدد من التدخلات النفسية في علاج اضطراب تعاطي المواد. اختيار التدخل المناسب يعتمد على المادة ومرحلة التغيير ودوافع المريض.



العلاج المعرفي السلوكي — CBT

يُعالج الأنماط الفكرية والسلوكية المرتبطة بالتعاطي ويُطور مهارات مواجهة الشغف والمثيرات.



المقابلة التحفيزية — MI

تُستخدم لتعزيز الدافعية الداخلية للتغيير. فعّالة بشكل خاص في مراحل التأمل والتردد.



العلاج الأسري ومجموعات الدعم

إشراك الأسرة في العلاج يرفع معدلات الاستبقاء. مجموعات الدعم (مثل NA/AA) توفر شبكة اجتماعية داعمة للتعافي.

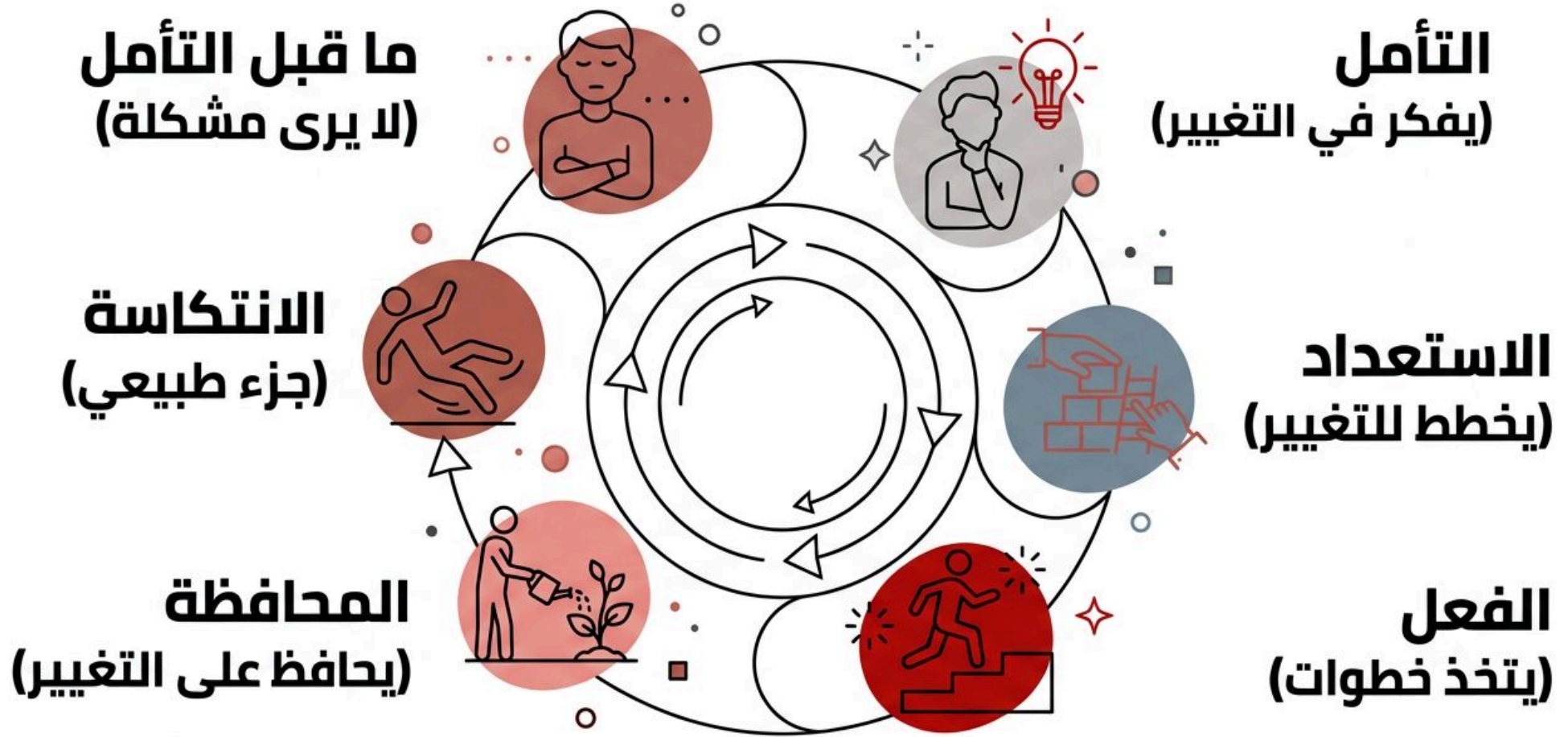


إدارة الطوارئ — CM

تعزيز الامتناع عبر نظام مكافآت ملموسة. أدلة قوية خاصة في إدمان المنشطات.

مراحل التغيير — Stages of Change

يصف نموذج Prochaska & DiClemente مسار التغيير السلوكي في الإدمان. فهم مرحلة المريض الحالية ضروري لاختيار التدخل الملائم.



الانتكاسة جزء طبيعي ومحتمل من العملية، ثم العودة لأي مرحلة سابقة

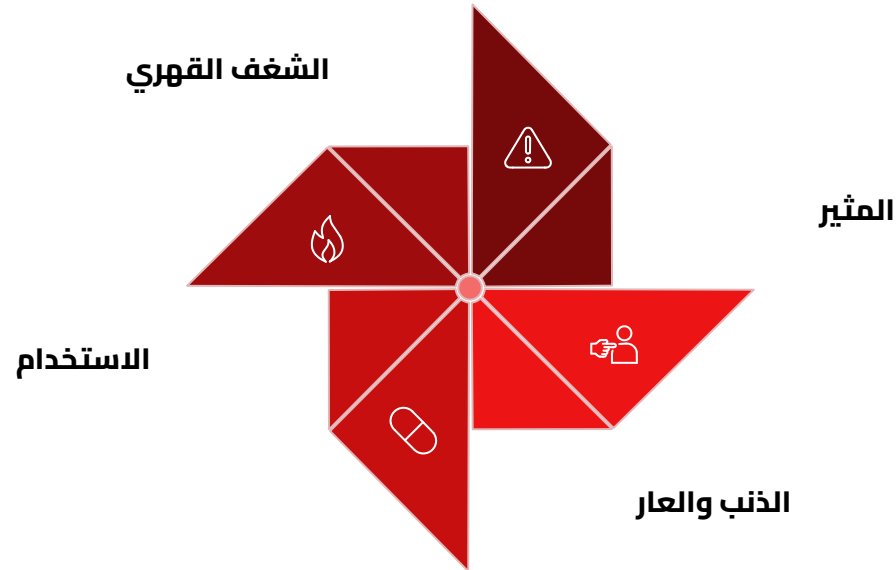
الانتكاسة جزء محتمل من الدورة وليست نهايتها. المتخصص يُقيّم المرحلة ويُعدّل استراتيجيته وفقاً لها، ولا يستخدم نفس الأسلوب مع جميع المرضى.

دورة الانتكاسة

الرسالة الأهم

الانتكاسة ليست فشلًا في العلاج، بل هي جزء من المسار الطبيعي للمرض المزمن.
معدلات الانتكاسة في الإدمان مشابهة لمعدلاتها في داء السكري وارتفاع ضغط الدم.

دورة الانتكاسة



التدخل العلاجي يستهدف قطع هذه الحلقة في أي نقطة، وتحديد مثيرات المريض المحددة مدخل رئيسي للوقاية.

التطبيق العملي

ربط المعرفة النظرية بالممارسة الإكلينيكية الفعلية



دراسة حالة — للنقاش الجماعي

أحمد، 28 عامًا — يُحضّر من قبل أسرته بعد حادث سيارة.

التاريخ النفسي والأسري
والده متوفى، علاقة

السيرة الحالية
يتعاطى الشبو منذ 3 سنوات، بدأها
بالحشيش في الجامعة. فقد عمله منذ
شهرين. ينام نهارًا ويسهر ليلاً ويتجنب
العائلة.